Resumos de Pediatria

Batistaz

Caderno de Estudos · Respiratório

IVAS na Criança

Do resfriado ao estridor

Internato de Pediatria

10º período · 2026.2

Sumário

Infecções de vias aéreas superiores · do resfriado ao estridor

I IVAS simples ou emergência? 3
Sinais de perigo e onde está a obstrução

II É só um resfriado? 4
Curso, o que não prescrever e quando suspeitar de complicação

III A dor de ouvido é otite média aguda? 5
Otoscopia, efusão e classificação do AIDPI

IV OMA: antibiótico ou observar? 6
Quem trata, com o quê, por quanto tempo e a falha

V Dor de garganta: viral ou estreptocócica? 8
Fenótipos, McIsaac, teste rápido e AIDPI

VI Como tratar a faringoamigdalite? 9
Benzatina, amoxicilina, alergia, falha e abscesso

VII O resfriado virou sinusite bacteriana? 10
Critérios, imagem, antibiótico e complicação orbitária

VIII Tosse ladrante e estridor: é crupe e quão grave? 12
Gravidade, dexametasona, adrenalina, internação

IX E quando não é crupe? 14
Epiglotite, traqueíte bacteriana e outros estridores

X Mapa de decisão e pegadinhas 15

XI Questões de estudo 16

— Gabarito, fontes e anotações 17

Como ler este caderno

Cai na prova
O que costuma ser cobrado ou confundido.

Conduta
O que fazer no plantão, em ordem.

Atenção
Armadilha clínica ou divergência entre diretrizes.

As chaves entre colchetes indicam a fonte de cada dado: [AIDPI] Ministério da Saúde, [SBP] crupe, [ABR] rinossinusites, [ABORL] antibióticos em IVAS, [CPS] crupe (Canadá, 2026), [AAP-O]/[AAP-S] otite e sinusite. Lista completa no fim.

Capítulo I

IVAS simples ou emergência?

Quase toda IVAS é viral e autolimitada. Primeiro, separar a criança com sinal de perigo ou via aérea ameaçada da que só precisa de orientação.

Sinais gerais de perigo (AIDPI, 2 meses a 5 anos)

- Não consegue beber ou mamar · vomita tudo o que ingere · convulsão ou movimento anormal há menos de 72 h.
- Letargia ou inconsciência · enchimento capilar > 2 s · batimento de asa de nariz e/ou gemência.
- Qualquer um deles, ou **estridor em repouso**: tratamento prévio e **referir com urgência** [AIDPI].

Onde está a obstrução: o som conta

Tabela 1 · *Estridor por segmento da via aérea*

Segmento	Som e voz	Exemplos e por que importa
Supraglote	Estridor inspiratório; **voz abafada** ("batata quente"); salivação se não consegue engolir	Epiglotite (supraglotite), abscesso retrofaríngeo. Sem cartilagem: **colapsa rápido** na inspiração [SBP]
Glote e subglote	Estridor inspiratório ou bifásico; **rouquidão e tosse ladrante**	Crupe viral, traqueíte bacteriana. A subglote é a porção mais estreita da via aérea da criança [SBP]
Traqueia intratorácica	Ruído mais audível na **expiração**	Compressões e lesões intratorácicas [SBP]

Cai na prova · 1 mm de edema

No lactente, 1 mm de edema na subglote reduz em 50% o calibre da traqueia. É por isso que um crupe que parece leve pode fechar a via aérea [SBP].

Atenção · saturação normal não tranquiliza

A via aérea superior estreita muito antes de a criança ficar hipoxêmica. Oxímetro em toda criança com estridor, mas **SatO2 normal não exclui obstrução grave**; hipoxemia documentada já é doença avançada, falência iminente e indicação de UTI [SBP].

Conduta · criança com estridor

- Manter **calma, no colo** do responsável; evitar manipulação e exames desnecessários: o choro aumenta o colapso da via aérea extratorácica [SBP].
- Toxemia, salivação e disfagia são bandeiras vermelhas de causa mais grave que o crupe [CPS].
- Via aérea ameaçada: o mais experiente, em ambiente controlado; sem levar à radiografia [SBP].

Capítulo II

É só um resfriado?

*Rinite viral e resfriado comum são o mesmo quadro. A criança pequena tem de **7 a 10 episódios por ano**; quase todos se resolvem sozinhos [RIN].*

Agentes e quadro

Rinovírus (várias cepas), coronavírus, influenza, parainfluenza, VSR, adenovírus e enterovírus [RIN]. Congestão, coriza, espirros, tosse, dor de garganta e mal-estar. A coriza pode ficar amarelada ou esverdeada no curso normal: **cor da secreção não define bactéria** [RIN] [ABR].

Quando pensar em complicação

- **Piora depois do 5º dia** ou sintomas por **mais de 10 dias**: suspeitar de rinossinusite pós-viral, que ainda não é bacteriana [RIN] (critérios no capítulo VII).
- Otalgia, dor de garganta com sinais de estreptococo, estridor, taquipneia ou febre que reaparece pedem reavaliação dirigida.
- Secreção nasal fétida e **unilateral**: pensar em corpo estranho nasal [ABR].

Tratamento: suporte

Tabela 2 · *O que fazer e o que não fazer no resfriado*

Medida	Veredito	Por quê
Antibiótico	**Não**	Sem benefício no resfriado nem na "rinite purulenta" aguda, mesmo com sintomas persistentes; efeitos adversos significativos [RIN]
Descongestionante (nasal ou oral), anti-histamínico	**Não de rotina**	Benefício limitado e risco de efeitos sistêmicos, sobretudo em criança [ABR]
Lavagem nasal com soro	Opção de conforto	Sem evidência suficiente em criança para recomendar como rotina; não prometer eficácia [ABR]
Antitérmico	Se desconforto	Tratar o desconforto, não o número do termômetro; não alternar [SBP-F]

Conduta · orientar a família

Voltar imediatamente se não conseguir beber ou mamar, piorar o estado geral, aparecer ou piorar a febre, ou respirar rápido ou com dificuldade [AIDPI]. Prevenção: higiene das mãos, evitar contato com sintomáticos, vacinação em dia (influenza, pneumococo) [RIN] [ABR].

Atenção · influenza no grupo de risco

A influenza A complica mais em menores de 2 anos e em cardiopatas, pneumopatas, nefropatas, hepatopatas e imunodeficientes [RIN]: seguir o protocolo de síndrome gripal do serviço.

Capítulo III

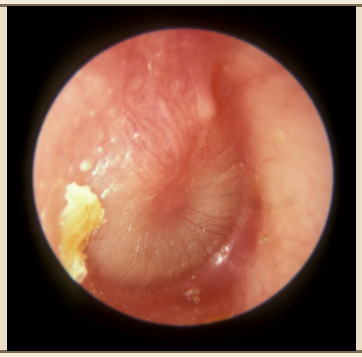
A dor de ouvido é otite média aguda?

Otite média aguda (OMA) é efusão na orelha média com inflamação aguda. Tímpano vermelho, sozinho, não é OMA: o achado que vale é o ***abaulamento****.*

Critérios diagnósticos (AAP, 6 meses a 12 anos)

- **Diagnosticar** com abaulamento moderado a intenso da membrana timpânica, ou otorreia nova que não seja otite externa.
- **Pode diagnosticar** com abaulamento leve + otalgia de início recente (< 48 h; no lactente, mexer ou puxar a orelha) ou hiperemia intensa.
- **Não diagnosticar** sem efusão na orelha média [AAP-O].

Hiperemia, opacidade e líquido retrotimpânico, isolados, não separam OMA de outras condições; o abaulamento é o sinal mais confiável [ABORL].



OMA. *Membrana abaulada, empurrada por secreção mucopurulenta na orelha média; perde-se o relevo do martelo.*



Efusão sem inflamação aguda *(otite média serosa, em adulto). Líquido amarelado atrás da membrana, sem abaulamento: não é OMA e não pede antibiótico.*

A classificação do AIDPI (2 meses a 5 anos)

Tabela 3 · *Problema de ouvido no AIDPI*

Achado	Classificação	Conduta
Tumefação ou vermelhidão dolorosa atrás da orelha	**Mastoidite**	1ª dose de antibiótico, analgésico, **referir com urgência**
Secreção purulenta há < 14 dias ou otoscopia alterada (opaca ou hiperemiada com abaulamento ou perfuração)	Infecção aguda do ouvido	Antibiótico por **8 dias**, analgésico, secar com mecha, retorno em 2 dias
Só dor de ouvido	Possível infecção aguda	Analgésico, retorno em 2 dias
Secreção há ≥ 14 dias	Infecção crônica	Secar com mecha, retorno em 5 dias

[AIDPI]. O manual recomenda usar o otoscópio sempre que possível.

Capítulo IV

OMA: antibiótico ou observar?

Toda OMA recebe analgesia desde o início [AAP-O] [ABORL]. Depois, decidir quem precisa de antibiótico já.

Tabela 4 · *Antibiótico imediato ou observação (AAP)*

Situação	6 a 23 meses	24 meses ou mais
***Grave**: otalgia moderada a intensa, otalgia ≥ 48 h ou T ≥ 39 °C*	Antibiótico	Antibiótico
*Não grave, **bilateral***	Antibiótico	Antibiótico ou observação
Não grave, unilateral	Antibiótico ou observação	Antibiótico ou observação
Otorreia	Antibiótico	

Observar só com seguimento garantido: iniciar antibiótico se piorar ou não melhorar em 48–72 h. [AAP-O]

Qual antibiótico e por quanto tempo

Tabela 5 · *Esquemas na OMA*

Fármaco	Dose	Quando e fonte
Amoxicilina	**50 mg/kg/dia** VO de 8/8 h (12/12 h na formulação BD) por **8 dias**	1ª linha do MS [AIDPI]
Amoxicilina	45–90 mg/kg/dia VO em 2–3 tomadas; pelo menos 10 dias nos casos de risco	Especialistas: dose alta não é 1ª opção no Brasil [ABORL]
Amoxicilina	80–90 mg/kg/dia VO em 2 tomadas	Referência americana [AAP-O]
Amoxicilina-clavulanato	90 mg/kg/dia de amoxicilina + 6,4 mg/kg/dia de clavulanato, em 2 tomadas	Amoxicilina em 30 dias, conjuntivite purulenta ou falha [AAP-O]
Cefuroxima	30 mg/kg/dia VO em 2 tomadas	Alergia não grave [ABORL] [AAP-O]
Claritromicina	15 mg/kg/dia VO	Alergia; azitromicina e cefaclor não (resistência) [ABORL]
Ceftriaxona	50 mg/kg/dia IM ou IV: 1–3 dias se não tolera VO; **3 dias na falha**	Intolerância à via oral ou falha [ABORL]

Duração pela AAP: 10 dias se < 2 anos ou grave; 7 dias de 2 a 5 anos e 5 a 7 dias a partir de 6 anos, se leve ou moderada [AAP-O].

Atenção · cada referência com o seu número

Dose e duração variam entre MS, especialistas brasileiros e AAP. Em prova que cita o MS ou o AIDPI: **amoxicilina 50 mg/kg/dia por 8 dias**; nas outras, identifique a fonte da questão.

Retorno em 2 dias: melhorou ou falhou?

Tabela 6 · *Consulta de retorno da infecção aguda do ouvido*

No retorno	Conduta
Sinal geral de perigo, tumefação ou dor atrás da orelha, ou febre ≥ 38,5 °C	Piorou: dose do antibiótico e **referir com urgência**
Dor de ouvido e febre persistem, em uso de amoxicilina	Subir a amoxicilina para **80 mg/kg/dia de 12/12 h** (formulação BD) **ou** trocar por amoxicilina-clavulanato; retorno em 48 h
Sem melhora no segundo retorno	Referir
Sem dor e sem secreção	Terminar o tratamento

[AIDPI]

Complicações que mudam tudo

Mastoidite, paralisia facial, sinais de meningite ou de complicação intracraniana e infecção sistêmica grave levam ao hospital [AIDPI] [NICE]. A lista de complicações supurativas inclui perfuração, mastoidite, meningite, abscessos subperiosteais, subdurais e intracranianos [ABORL].

Prevenção

- Vacinas pneumocócica e contra influenza em dia; aleitamento materno exclusivo por pelo menos 6 meses; evitar fumaça de tabaco [AAP-O].
- **Não** usar antibiótico profilático de rotina para OMA recorrente [AAP-O].

Cai na prova · o que a OMA não é

- Tímpano só hiperemiado, opaco ou com líquido, sem abaulamento nem otorreia [ABORL].
- Otite com efusão sem sintomas agudos: observar, não tratar com antibiótico [AAP-O].
- Secreção há 14 dias ou mais: infecção crônica, outro manejo [AIDPI].

Conduta · roteiro da OMA no pronto-socorro

- Otoscopia: há abaulamento ou otorreia? Sem efusão, não é OMA.
- Analgesia já (paracetamol, dipirona ou ibuprofeno, em mg/kg).
- Antibiótico pela gravidade, idade e lateralidade; amoxicilina na dose da referência adotada.
- Retorno em 2 dias (AIDPI) ou em 48–72 h na observação; orientar sinais de retorno imediato.

Capítulo V

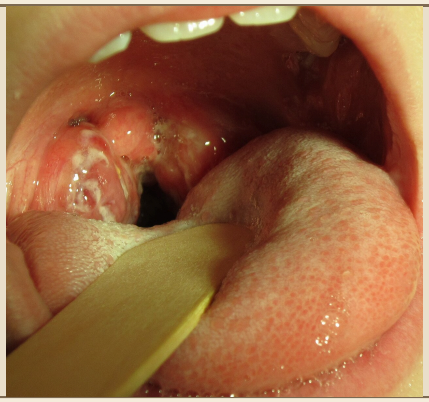
Dor de garganta: viral ou estreptocócica?

O estreptococo do grupo A (S. pyogenes) responde por 20% a 40% das faringoamigdalites, mas antibiótico é prescrito em 55% a 75% delas [ABORL]. O motivo de tratar o estreptococo é prevenir a febre reumática.

Tabela 7 · *Pistas clínicas*

Favorece vírus	Favorece estreptococo
Tosse, coriza, conjuntivite, rouquidão	Odinofagia de início súbito, febre
Úlceras ou vesículas orais	Petéquias no palato
Diarreia	Exsudato ou edema amigdaliano
Início gradual	Adenopatia cervical anterior dolorosa; exantema escarlatiniforme

[ABORL]



Faringoamigdalite estreptocócica *com cultura positiva, em criança de 8 anos: exsudato amigdaliano. Foto sozinha não confirma o agente.*

Escore de McIsaac (Centor modificado)

Tabela 8 · *1 ponto para cada item*

Item	Probabilidade de estreptococo
Febre > 38 °C · ausência de tosse · adenopatia cervical anterior dolorosa · exsudato ou edema amigdaliano · idade 3–14 anos	0–1 ponto: 7,6–13,1% · 2–3 pontos: 20,8–33,6% · 4–5 pontos: 50,7–69,3% [IDSA]

A IDSA (2025) sugere usar um escore para decidir **quem testar**, não quem tratar, e **não** aplica o escore abaixo de 3 anos, idade em que o estreptococo não se apresenta de forma típica. Mesmo com escore baixo, testar quem tem contato domiciliar com estreptococo, antecedente de febre reumática ou sinal de complicação [IDSA]. Os especialistas brasileiros lembram que o escore é menos útil em criança e que vale o quadro global [ABORL].

Exames

- **Teste rápido**: especificidade ~95%, sensibilidade 60–90%. Positivo confirma em criança sintomática; negativo, se bem feito, exclui pela ABORL; não separa doença de portador crônico [ABORL].
- **Cultura de orofaringe**: padrão-ouro, resultado em 48–72 h [ABORL].
- **ASLO não** diagnostica faringite aguda: sobe só a partir da 1ª semana e tem pico em 4–6 semanas. Hemograma e PCR não separam a etiologia [ABORL].

Capítulo VI

Como tratar a faringoamigdalite?

AIDPI (2 meses a 5 anos)

- **Grave** (sinal de perigo, abaulamento de palato, membranas branco-acinzentadas): 1ª dose de antibiótico e referir com urgência.
- **Moderada** (gânglios cervicais aumentados e dolorosos, ou amígdalas hiperemiadas com pontos purulentos ou petéquias no palato): antibiótico, analgésico, retorno em 2 dias.
- **Leve** (vesículas ou hiperemia com sinais de resfriado): só analgésico [AIDPI].

Pelo escore (especialistas)

- **≥ 4**: tratar.
- **2–3**: teste rápido ou cultura; sem teste, tratar já (se não houver como seguir) ou reavaliar em 48–72 h.
- **≤ 1**: sintomáticos [ABORL].

O antibiótico iniciado até o **9º dia** ainda previne febre reumática: dá para esperar o exame [ABORL].

Tabela 9 · *Esquemas contra o estreptococo do grupo A*

Fármaco	Dose	Observação
Penicilina G benzatina	IM, dose única: **< 20 kg 600.000 UI · ≥ 20 kg 1.200.000 UI**	1ª linha do MS [AIDPI]. Especialistas usam corte de 27 kg [ABORL]
Amoxicilina	50 mg/kg/dia VO em 3 tomadas por **10 dias**	7 dias pode não erradicar o estreptococo nem prevenir febre reumática [ABORL] [AIDPI]. Na mononucleose, dá exantema [NICE]
Penicilina V	< 12 anos: 90.000 UI/kg/dia VO em 3 tomadas por 10 dias	[ABORL]
Claritromicina	15 mg/kg/dia VO em 2 tomadas, máx. 250 mg/dose	Alergia à penicilina [ABORL]
Eritromicina	40 mg/kg/dia VO em 2 tomadas por 10 dias	Alergia à penicilina [ABORL]
Cefadroxila · cefalexina · clindamicina	50 mg/kg/dia em 2 tomadas · 50 mg/kg/dia em 4 · 20 mg/kg/dia em 3; todos por 10 dias	Falha com penicilinas [ABORL]

Retorno e complicações

- Retorno em 2 dias (AIDPI): melhorou com amoxicilina, completar 10 dias; gânglios inalterados, trocar de antibiótico (benzatina, se não foi usada) ou referir [AIDPI].
- Abscesso peri, para ou retrofaríngeo, toxemia, estridor, desidratação ou dor intensa: antibiótico, avaliar drenagem e internar [ABORL]; também sepse e síndrome de Lemierre [NICE].

Atenção · curso curto e outros países

O NICE aceita penicilina V por 5–10 dias (5 aliviam os sintomas; 10 erradicam melhor) [NICE]. No Brasil, onde a febre reumática ainda importa, o curso oral é de **10 dias** [ABORL] [AIDPI].

Capítulo VII

O resfriado virou sinusite bacteriana?

Toda IVAS inflama os seios: a rinossinusite viral é a regra. Até 7,5% dos quadros virais da criança evoluem para rinossinusite aguda bacteriana (RSAB) [ABR]. O diagnóstico é pela evolução no tempo, não pela cor da secreção nem pela radiografia.

Tabela 10 · *Quando considerar RSAB*

Padrão	Brasil (ABR 2024)	AAP (2013)
Dupla piora	Piora importante depois da melhora dos **primeiros 5 dias**	Piora (ou nova febre) depois de melhora inicial
Persistência	Quadro intenso **sem melhora gradual após 14 dias**	Secreção nasal e/ou tosse diurna por **mais de 10 dias** sem melhora
Início grave	—	Febre ≥ 39 °C + secreção purulenta por 3 dias seguidos

[ABR] [AAP-S]. Na criança pequena a tosse predomina e a dor facial é rara; ausência de dor não exclui.

Agentes e anatomia

H. influenzae (45%), *S. pneumoniae* (32%) e *M. catarrhalis* (16%) [ABR]. Etmoide e maxilar existem ao nascer; o seio frontal começa a se formar por volta dos 4 anos e só aparece à TC na maioria aos 12 [ABR]: "sinusite frontal" no lactente não existe.

Exames

Diagnóstico clínico. **Não pedir radiografia**: o velamento é inespecífico e aparece em quase toda IVAS com 6 dias ou mais. TC só na falha do tratamento adequado ou na suspeita de complicação [ABR] [AAP-S].

Tratamento

- Como a RSAB da criança costuma se resolver sozinha, cabe **observação inicial**; tratar logo os casos moderados ou graves e quem tem doença que pode piorar (asma, por exemplo) [ABR]. A AAP trata já o início grave e a dupla piora, e permite observar a persistente por mais 3 dias [AAP-S].
- **Amoxicilina 25–50 mg/kg/dia** de 8/8 ou 12/12 h por **7 a 10 dias**; 90 mg/kg/dia se suspeita de pneumococo resistente. Amoxicilina-clavulanato na mesma dose para produtores de betalactamase ou falha [ABR].
- Alergia: axetilcefuroxima 25–50 mg/kg/dia de 12/12 h ou claritromicina 15 mg/kg/dia de 12/12 h, 7 a 10 dias; cefalosporina não, se a reação à penicilina foi grave [ABR].
- Sem via oral: ceftriaxona 50 mg/kg IV ou IM, 3 doses em 3 dias, e depois via oral [ABR].
- Reavaliar se piorar ou não melhorar em 72 h [AAP-S].

Complicação orbitária: a que mais aparece

A órbita responde por 60% a 80% das complicações da rinossinusite aguda; é mais comum na criança pequena e parte, em geral, do etmoide [ABR].

Atenção · sinais de alerta orbitário

Edema e hiperemia periorbitária, **proptose**, dor ou restrição da movimentação ocular, **diplopia** e queda da acuidade visual [ABR]. Cefaleia frontal intensa, meningismo ou déficit focal também levam ao hospital [NICE].

Tabela 11 · *Complicações orbitárias*

Estágio	O que se vê
Celulite pré-septal (periorbitária)	Só a pálpebra, à frente do septo orbitário; sem proptose nem alteração de visão ou movimento ocular. Leve (pálpebra < 50% fechada): amoxicilina-clavulanato em dose alta por via oral e reavaliação diária; internar se não melhorar em 24–48 h [AAP-S]
Celulite orbitária	Edema difuso do conteúdo da órbita, sem abscesso; pode haver proptose; visão e mobilidade podem cair
Abscesso subperiosteal	Coleção entre a periórbita e a parede; proptose maior, olho deslocado para baixo e para fora, dor ao mover
Abscesso orbitário	Coleção no conteúdo da órbita; proptose e quemose intensas; perda visual grave
Trombose do seio cavernoso	Pode atingir o olho oposto; prostração e meningismo

[ABR] [AAP-S]

Conduta · suspeita de complicação

- **TC com contraste** é o exame de escolha; RM se houver suspeita intracraniana [ABR].
- Internar, antibiótico IV com cobertura de aeróbios e anaeróbios, avaliação oftalmológica seriada; otorrino e oftalmo juntos [ABR].
- Celulite sem perda visual pode ser tratada clinicamente; piora visual ou falta de melhora em 48 h pede cirurgia. **Abscesso** subperiosteal ou orbitário: em geral drenagem cirúrgica, salvo raras exceções [ABR].

Cai na prova · o que não fazer na rinossinusite

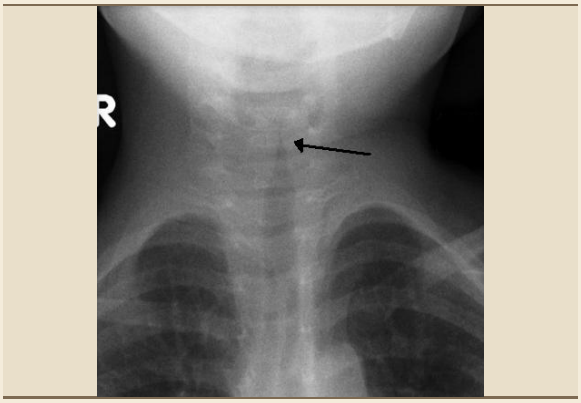
- Radiografia para decidir antibiótico.
- Antibiótico só porque a secreção é amarela ou verde.
- Descongestionante, anti-histamínico e lavagem como rotina na criança [ABR].
- Profilaxia antibiótica na recorrente, fora de casos excepcionais (imunodeficiência) [ABR].

Capítulo VIII

Tosse ladrante e estridor: é crupe e quão grave?

*Crupe é a síndrome de **rouquidão, tosse ladrante, estridor predominantemente inspiratório** e graus variados de desconforto respiratório. Viral, é a causa de cerca de 90% dos estridores na criança [SBP].*

- **Vírus:** parainfluenza 1, 2 e 3, influenza A e B, VSR; *Mycoplasma* acima de 5 anos [SBP].
- **Idade:** típica de 6 meses a 3 anos [CPS]; a SBP fala em 1 a 6 anos, pico aos 18 meses, mais em meninos [SBP].
- **Curso:** coriza e febre baixa; após 12–48 h, tosse ladrante e estridor, que costumam piorar à noite. Resolve em 3–7 dias [SBP] [CPS].
- **Diagnóstico clínico.** A radiografia é normal em metade dos casos; fica para dúvida (corpo estranho) ou curso atípico [SBP].



Sinal da torre de igreja *(seta): estreitamento subglótico em radiografia AP. Pode existir em criança sadia e falta em metade dos crupes: não é exame de rotina.*

Tabela 12 · *Gravidade do crupe pela clínica*

	Leve	Moderado	Grave	Falência iminente
Tosse ladrante	Ocasional	Frequente	Frequente	Pode sumir por fadiga
Estridor em repouso	Nenhum ou mínimo	Audível	Proeminente, às vezes também expiratório	Pode ficar baixo
Retração	Nenhuma ou leve	Visível em repouso	Intensa	Pode não ser marcada
Agitação ou letargia	Não	Pouca ou nenhuma	Letargia pode aparecer	Letargia, rebaixamento
Cianose	Não	Não	Não	Acinzentado ou cianótico

[CPS]. A SBP traz um escore de estridor, retração, entrada de ar, cor e consciência; os escores de pesquisa não melhoraram o cuidado clínico [SBP] [CPS].

Atenção · a criança que "melhorou" ficando quieta

Estridor e tosse que diminuem junto com cansaço, letargia ou cor acinzentada não são melhora: são falência respiratória chegando [CPS]. Menor de 6 meses, estridor em repouso, alteração de consciência ou hipercapnia indicam risco de falência [SBP].

Tratamento

Tabela 13 · *Crupe viral: o que dar e quando*

Gravidade	Conduta
Leve	Dexametasona 0,15–0,3 mg/kg, dose única · alta para casa [SBP]
Moderado	Adrenalina nebulizada · dexametasona 0,3–0,6 mg/kg ou budesonida inalatória 2 mg · observar 3–4 h: alta ou internação [SBP]
Grave	Adrenalina nebulizada · dexametasona 0,6 mg/kg IM · UTI [SBP]

Corticoide: para todos

Reduz gravidade, internação, UTI e uso de adrenalina [SBP]. **Dexametasona dose única**, VO ou parenteral, de 0,15 mg/kg (leve) a 0,6 mg/kg (grave) [SBP]. A CPS usa **0,6 mg/kg VO** para qualquer gravidade, a dose dos ensaios, e considera incerta a equivalência das doses menores; IM se vomita ou está em sofrimento importante. Efeito começa em 2–3 h e dura 24–48 h [CPS].

Adrenalina: moderado e grave

Adrenalina 1:1.000 nebulizada, **sem diluir**: **0,5 mL/kg, máximo 5 mL** (5 ampolas) [SBP]; a CPS usa 5 mL para qualquer peso. Age em 10–30 min e o efeito some em cerca de 2 h: o desconforto pode voltar [SBP] [CPS]. Também indicada em quem teve manipulação prévia da via aérea [SBP].

Internação, UTI e via aérea

- **Internar**: toxemia, desidratação ou não consegue beber, estridor importante ou retração em repouso, sem resposta à adrenalina ou piora após 2 h dela [SBP].
- **Hipoxemia**: oxigênio (a nebulização usa O2 como fonte) [SBP]. **UTI**: crupe grave e qualquer hipoxemia; sofrimento grave sem resposta sustentada pede terapia intensiva ou anestesia [SBP] [CPS].
- **Intubação**: ambiente controlado, o mais experiente; cânula **0,5 mm menor** que a calculada para a idade [SBP].
- **Alta** depois de dexametasona e adrenalina: sem recorrência dos sintomas por 2–4 h de observação [CPS].

Cai na prova · o que não funciona no crupe

Nebulização com soro ou ar umidificado (e tenda) não tem eficácia; se agitar a criança, piora [SBP] [CPS]. Antibiótico e broncodilatador β2 raramente têm lugar no crupe típico; budesonida somada à dexametasona não acrescenta [CPS].

Atenção · crupe que repete ou foge do padrão

Abaixo de 6 meses, recorrente, prolongado ou grave sem explicação: investigar estreitamento congênito ou adquirido da via aérea (refluxo, papilomatose, estenose) [SBP] [CPS].

Capítulo IX

E quando não é crupe?

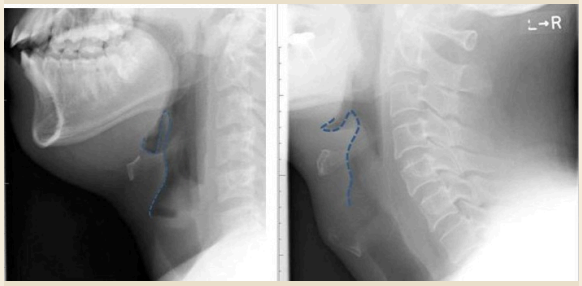
Febre alta, aspecto tóxico, salivação e disfagia mudam o diagnóstico. O crupe viral é de criança com bom estado geral [CPS] [SBP].

Tabela 14 · *Diagnóstico diferencial do estridor agudo*

Condição	O que aponta para ela
***Epiglotite** (supraglotite)*	**Sem tosse ladrante nem rouquidão**; febre alta de início súbito, disfagia, salivação, aspecto tóxico e ansioso, sentada para frente, cabeça em "posição de cheirar" [CPS] [SBP]
Traqueíte bacteriana	Crupe grave + febre alta e toxemia; **não responde à adrenalina** nem ao corticoide [CPS] [SBP]
Abscesso retro, para ou peritonsilar	Febre alta, dor cervical, dor de garganta e disfagia; depois torcicolo, salivação, estridor [CPS]
Corpo estranho	Engasgo, sibilo, rouquidão, estridor bifásico, entrada de ar diminuída [CPS]
Anafilaxia, angioedema	Início rápido de disfagia, sibilo, estridor, urticária [CPS]

Epiglotite

A supraglote, sem cartilagem, colapsa rápido e pode obstruir de forma letal [SBP]. A vacina contra *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib) reduziu muito os casos [SBP]. Na suspeita: criança no colo, sem agitar, equipe de via aérea avançada; o resto (antibiótico, exames) vem depois da via aérea garantida.



Perfil cervical. *À esquerda, epiglote normal, fina (contorno tracejado); à direita, epiglote espessada ("sinal do polegar"). Na suspeita, a via aérea vem antes da radiografia.*

Traqueíte bacteriana

Rara, mas hoje a principal causa de obstrução alta grave em UTI após a vacina Hib. Principal agente: *S. aureus*; também estreptococos, *Moraxella* e *Haemophilus* [SBP]. Membranas purulentas obstruem a traqueia. Conduta: **UTI**, intubação no centro cirúrgico com endoscopia (diagnóstico, limpeza e cultura), intubação por 3–7 dias e antibiótico IV com cefuroxima ou ceftriaxona. Corticoide e adrenalina inalatória não têm papel [SBP].

Cai na prova · crupe viral × traqueíte bacteriana

Os dois têm tosse ladrante e rouquidão. A traqueíte tem toxemia, sintomas circulatórios, secreção purulenta, falta de resposta à adrenalina, quase sempre intubação e UTI [SBP].

Capítulo X

Mapa de decisão e pegadinhas

1 · Perigo?	Não bebe, vomita tudo, convulsão, letargia, TEC > 2 s, gemência, estridor em repouso → referir/estabilizar.
2 · Estridor	Calma, colo, oxímetro. Tosse ladrante e rouquidão: crupe. Tóxico, saliva, sem tosse ladrante: epiglotite. Sem resposta à adrenalina: traqueíte.
3 · Ouvido	Abaulamento moderado/intenso ou otorreia nova (não otite externa) = OMA. Analgesia já. Antibiótico por gravidade, idade e lateralidade; retorno em 2 dias.
4 · Garganta	Pistas virais: sintomáticos. Pistas estreptocócicas: teste ou tratar (benzatina ou amoxicilina 10 dias).
5 · Nariz	Resfriado: suporte. Dupla piora após 5 dias ou quadro intenso sem melhora em 14 dias (ABR): pensar em RSAB. Olho inchado: TC e internação.
6 · Não fazer	Antibiótico no resfriado, RX de seios ou de pescoço de rotina, ASLO na faringite aguda, nebulização com soro no crupe, descongestionante de rotina.

Tabela 15 · *Pegadinhas de decisão*

Afirmação tentadora	Correção
Tímpano vermelho, é OMA	Hiperemia isolada não distingue OMA; o sinal que vale é o abaulamento
Líquido no ouvido depois do tratamento, antibiótico falhou	Efusão residual sem sintoma é otite com efusão: observar
Coriza verde, sinusite bacteriana	Cor não define bactéria; vale a evolução no tempo
Radiografia com velamento confirma sinusite	Velamento é inespecífico e aparece em qualquer IVAS
ASLO alto confirma faringite estreptocócica	ASLO sobe semanas depois; não serve para o quadro agudo
Amoxicilina por 7 dias basta na faringite	Erradicar o estreptococo e prevenir febre reumática pede 10 dias
Saturação 98%, o estridor não é grave	Hipoxemia é tardia; avaliar esforço, estridor em repouso e consciência
Melhorou com adrenalina, pode ir embora	O efeito acaba em ~2 h: observar 2–4 h depois da **última adrenalina**
Crupe que não melhora com adrenalina é só mais grave	Pensar em traqueíte bacteriana: UTI e via aérea

Capítulo XI

Questões de estudo

1. Menina de 14 meses, febre de 38,3 °C e otalgia há 1 dia; membrana timpânica direita hiperemiada e abaulada, esquerda normal; bom estado geral. Pelo AIDPI:

A Só analgésico e retorno em 5 dias.
B Amoxicilina 50 mg/kg/dia por 8 dias, analgésico e retorno em 2 dias.
C Amoxicilina-clavulanato por 14 dias.
D Ceftriaxona IM dose única e alta sem retorno.

2. Menino de 8 anos, 30 kg: dor de garganta súbita, febre de 38,8 °C, sem tosse, exsudato amigdaliano, linfonodos cervicais dolorosos. Conduta adequada:

A Dosar ASLO e tratar se elevado.
B Penicilina benzatina 1.200.000 UI IM, dose única.
C Amoxicilina por 5 dias.
D Azitromicina por 3 dias como primeira escolha.

3. Criança de 4 anos com coriza e tosse há 7 dias, que melhorava e há 2 dias piorou, com secreção purulenta e febre. É correto:

A A radiografia dos seios da face confirma o diagnóstico.
B A dupla piora após os primeiros 5 dias sugere rinossinusite bacteriana.
C Secreção verde por si só indica antibiótico.
D A sinusite frontal é a mais comum nessa idade.

4. Lactente de 18 meses, coriza há 2 dias e, à noite, tosse ladrante, rouquidão, estridor e retração em repouso; ativo, SatO2 97%. A conduta inicial é:

A Radiografia cervical para confirmar o sinal da torre.
B Nebulização com soro fisiológico e alta.
C Adrenalina nebulizada e dexametasona, com observação de algumas horas.
D Ceftriaxona e internação.

5. Menino de 5 anos, não vacinado: febre alta súbita, voz abafada, salivação, disfagia, inclinado para frente, sem tosse ladrante. Conduta:

A Examinar a orofaringe com abaixador de língua para ver a epiglote.
B Enviar à radiologia para perfil cervical antes de qualquer medida.
C Manter no colo, sem agitar, e acionar a equipe de via aérea avançada.
D Adrenalina nebulizada e alta após 2 horas.

6. Sobre otite média aguda, é correto:

A A analgesia só deve começar se o antibiótico falhar.
B Efusão sem sintomas após o tratamento pede novo antibiótico.
C Na falha em 2 dias, o AIDPI sobe a amoxicilina para 80 mg/kg/dia.
D Hiperemia isolada da membrana basta para o diagnóstico.

Gabarito comentado

1 · B. Otoscopia alterada (hiperemia com abaulamento) = infecção aguda do ouvido: amoxicilina por 8 dias, analgésico e retorno em 2 dias [AIDPI].

2 · B. Quadro típico de estreptococo (McIsaac 5). Benzatina dose única: 1.200.000 UI, acima dos cortes do AIDPI (20 kg) e da ABORL (27 kg) [AIDPI] [ABORL]. ASLO não serve no agudo; amoxicilina seria por 10 dias [ABORL].

3 · B. Dupla piora após o 5º dia é critério de RSAB. Radiografia não confirma; a cor da secreção não decide; o seio frontal só começa a se desenvolver por volta dos 4 anos, e a sinusite frontal não é a localização típica nessa idade [ABR].

4 · C. Crupe moderado (estridor e retração em repouso): adrenalina nebulizada e dexametasona, observar 3–4 h [SBP] [CPS]. Radiografia e nebulização com soro não ajudam.

5 · C. Epiglotite: não agitar, não examinar a orofaringe à força, não levar ao RX; via aérea com a equipe mais experiente [SBP] [CPS].

6 · C. No retorno, subir para 80 mg/kg/dia de 12/12 h (BD) ou trocar por amoxicilina-clavulanato [AIDPI]. Analgesia é desde o início, e efusão residual é otite com efusão [AAP-O].

Apêndice

Fontes e anotações

- [AIDPI] BRASIL. Ministério da Saúde; OPAS. *Manual de quadros de procedimentos: AIDPI Criança, 2 meses a 5 anos*. Brasília, 2017.
- [SBP] SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Departamento de Emergências. *Crupe viral e bacteriano*. Guia Prático de Conduta n.º 1, jan. 2017.
- [SBP-F] SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. *Manejo da febre aguda*. Documento científico, 2021.
- [RIN] ASBAI; SBP; ABORL-CCF. *V Consenso Brasileiro sobre Rinites*, 2024 (rinites infecciosas).
- [ABR] ABORL-CCF; ACADEMIA BRASILEIRA DE RINOLOGIA. *Rinossinusites: evidências e experiências*, 2024.
- [ABORL] ABORL-CCF. *I Campanha sobre uso de antibióticos em infecções de vias aéreas superiores* (otite, faringotonsilite).
- [AAP-O] LIEBERTHAL, A. S. et al. The diagnosis and management of acute otitis media. *Pediatrics*, v. 131, e964, 2013.
- [AAP-S] WALD, E. R. et al. Clinical practice guideline for acute bacterial sinusitis in children aged 1 to 18 years. *Pediatrics*, v. 132, e262, 2013.
- [CPS] CANADIAN PAEDIATRIC SOCIETY. *Acute management of croup in the emergency department*. 2017, atualizado em 6 mar. 2026.
- [IDSA] INFECTIOUS DISEASES SOCIETY OF AMERICA. *Clinical practice guideline update on group A streptococcal pharyngitis*, parte 1 (seleção para teste), 2025.
- [NICE] NICE. NG91 *Otitis media (acute)*; NG84 *Sore throat (acute)*; NG79 *Sinusitis (acute)*: antimicrobial prescribing.

Créditos das imagens

- *Croup steeple sign.jpg*: Frank Gaillard, CC BY-SA 3.0. Wikimedia Commons.
- *Acute Otitis Media Stage of Resolution.jpg*: Michael Hawke MD, CC BY 4.0. Wikimedia Commons.
- *Adult Serous Otitis Media.jpg*: Michael Hake MD, CC BY-SA 4.0. Wikimedia Commons.
- *Strep throat2010.JPG*: James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0. Wikimedia Commons.
- *Compare epiglottis.jpg*: Med Chaos, CC BY-SA 3.0. Wikimedia Commons.